

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE ESQUEMAS DE YOUNG — FORMA CORTA 3 (YSQ-S3)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación Dimensional de los 18 Esquemas Tempranos Desadaptativos

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Esquemas de Young — Forma Corta 3 (YSQ-S3).
Nombre Original (Inglés)	<i>Young Schema Questionnaire – Short Form 3 (YSQ-S3)</i>
Autor Original	Dr. Jeffrey E. Young (2005), Schema Therapy Institute, Nueva York.
Validaciones Hispánicas	Calvete et al. (2013, España); Cid et al. (2013, Chile); Landa-Ramírez et al. (2020).
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Terapia de Esquemas, Esquemas Tempranos Desadaptativos (ETD).
Tipo de Instrumento	Autoinforme dimensional de 90 reactivos estructurados en escala Likert de 6 puntos (1 a 6).
Población y Rango	Adultos y jóvenes (desde 16 años). Trastornos de la personalidad, trauma relacional y depresión crónica.
Tiempo de Administración	15 a 20 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Instrumento científico registrado; adquisición oficial vía Schema Therapy Institute / ISST.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y TEORÍA DE ESQUEMAS DE JEFFREY YOUNG

En el modelo de la Terapia de Esquemas (Young, Klosko & Weishaar, 2003), los **Esquemas Tempranos Desadaptativos (ETD)** se definen como patrones cognitivos, afectivos y memorísticos estables y autoderrotistas que se originan durante la infancia o adolescencia a partir de la interacción entre el temperamento biológico del niño y la frustración crónica de cinco necesidades emocionales nucleares básicas: apego seguro, autonomía y competencia, límites realistas y autocontrol, libertad de expresión, y espontaneidad y juego.

Los ETD actúan como filtros rígidos a través de los cuales la persona procesa las experiencias relacionales. Frente a la activación de un esquema, el individuo recurre típicamente a tres estilos de afrontamiento desadaptativos: (a) **Rendición** (someterse al esquema confirmándolo pasivamente), (b) **Evitación** (desconexión afectiva, aislamiento o adicciones para no sentir el dolor del esquema), o (c) **Sobrecompensación** (actuar de forma opuesta al esquema de manera defensiva y hostil).

A nivel neurobiológico, los esquemas se vinculan a memorias somáticas implícitas codificadas en la amígdala e ínsula anterior con escasa modulación de la corteza prefrontal ventromedial (vmPFC), desencadenando secuestros emocionales ante claves de rechazo o abandono.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE LOS 18 ESQUEMAS (5 ÍTEMS C/U)

Dominio Temático Nuclear	Esquemas (18)	Contenido Esquemático y Creencia Nuclear Subyacente
I. Desconexión y Rechazo	AB, DA, DE, IV, AS	Abandono, Desconfianza/Abuso, Deprivación Emocional, Imperfección, Aislamiento Social. Creencia: "Nadie satisfará mis necesidades de afecto y seguridad".
II. Autonomía Deteriorada	DI, VH, EM, FR	Dependencia, Vulnerabilidad al Daño, Apego confuso/Apego inmaduro, Fracaso. Creencia: "No puedo funcionar ni sobrevivir de forma independiente".
III. Límites Insuficientes	ME, AI	Merecimiento/Grandiosidad, Autocontrol Insuficiente. Dificultad para respetar los derechos de los demás o posponer la gratificación inmediata.
IV. Orientación hacia Otros	SB, AS, BR	Subyugación, Autosacrificio, Búsqueda de Aprobación. Priorización absoluta de los deseos ajenos para obtener afecto o evitar represalias.
V. Sobrevigilancia e Inhibición	NP, IE, EI, CP	Negatividad/Pesimismo, Inhibición Emocional, Estándares Inflexibles, Castigo. Supresión de la espontaneidad por miedo a catástrofes o culpas.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Notable precisión en las 18 escalas: coeficientes alfa de Cronbach oscilan entre 0.76 y 0.93 en muestras clínicas hispanoparlantes (Calvete et al., 2013; Cid et al., 2013). La fiabilidad test-retest a los 3 meses se sitúa entre $r = 0.72$ y $r = 0.86$, demostrando la estabilidad del constructo rasgo esquemático.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio corrobora la estructura de 18 factores de primer orden correlacionados subordinados a los 5 dominios de segundo orden ($CFI = 0.91$, $RMSEA = 0.048$), confirmando la adecuación métrica de la forma abreviada de 90 reactivos frente a la extensa de 232.
Validez Clínica Concurrente y	Fuertes correlaciones con diagnósticos de Trastornos de la Personalidad (SCID-II): Abandono y Desconfianza discriminan con alta sensibilidad el TLP; Estándares Inflexibles discrimina el Trastorno Obsesivo-Compulsivo de la Personalidad; Imperfección se asocia fuertemente al Trastorno por Evitación.
Sensibilidad al Cambio	El YSQ-S3 es el patrón de referencia para medir la remisión estructural en ensayos clínicos de Terapia de Esquemas, mostrando descensos significativos (> 1.2 DE) en las puntuaciones medias de esquemas activos tras 12 a 18 meses de terapia intensiva.
Invarianza Transcultural	Equivalencia métrica ratificada entre adaptaciones españolas y latinoamericanas; las mujeres presentan puntuaciones medias más elevadas en Autosacrificio y los varones en Grandiosidad e Inhibición Emocional.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Los 90 ítems se responden en una escala Likert de 6 puntos (1 = «Totalmente falso de mí», 2 = «La mayor parte de las veces falso», 3 = «Más falso que verdadero», 4 = «Moderadamente verdadero», 5 = «La mayor parte de las veces verdadero», 6 = «Me describe perfectamente»):

- **Paso 1 (Cálculo Directo):** No contiene reactivos invertidos. Cada esquema se evalúa mediante un bloque exacto de 5 reactivos.
- **Paso 2 (Puntuación por Esquema):** Se suman los 5 ítems de cada esquema (rango: 5 a 30 puntos) o se calcula la media dividiendo entre 5 (rango: 1.0 a 6.0 puntos).
- **Paso 3 (Criterio de Activación Esquemática de Young):** Un esquema se considera **clínicamente activo y disfuncional** si la puntuación media es $\geq 3.5 - 4.0$, o si el paciente marca con **5 o 6** al menos dos de los cinco reactivos que componen el esquema.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y SIGNIFICACIÓN DIAGNÓSTICA

Rango Clínico	Puntuación Media	Nivel de Activación	Significación Clínica y Repercusión Funcional
Muy Bajo / Inactivo	1.00 a 1.99	Esquema latente / Ausente	Creencia inoperativa; el paciente posee una visión equilibrada y adaptativa en dicha área.
Bajo / Sub-clínico	2.00 a 3.49	Activación débil / Situacional	Aparición de dudas esquemáticas menores únicamente ante estresores relacionales muy específicos.
Moderado / Activo	3.50 a 4.49	Esquema activo (corte ≥ 3.5)	Patrón disfuncional consolidado. Distorsión evaluativa evidente. Foco primario de intervención.
Severo / Arraigado	4.50 a 6.00	Esquema central dominante	Organización nuclear de la personalidad; detonación afectiva severa; altísimo impacto en relaciones íntimas.

REGLA CLÍNICA DE JERARQUIZACIÓN TERAPÉUTICA DE ESQUEMAS:

En la práctica clínica es contraproducente abordar los 18 esquemas simultáneamente. Se debe priorizar la intervención sobre los esquemas del **Dominio I (Desconexión y Rechazo)**, especialmente Abandono e Imperfección, dado que sustentan las angustias vinculares más primitivas y actúan como "esquemas nodales" de los que derivan defensivamente la sumisión o el autosacrificio.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA EN TERAPIA DE ESQUEMAS (JEFFREY YOUNG)

PROTOCOLO CLÍNICO BASADO EN EL PERFIL DEL YSQ-S3:

- **Paso 1 (Mapeo y Psicoeducación):** Identificar los 2-3 esquemas centrales (media ≥ 4.0). Trazar su origen biográfico infantil y conectar con la frustración de necesidades básicas no cubiertas.
- **Paso 2 (Trabajo Vivencial con Modos):** Utilizar la técnica de **Rescritura en Imaginación (Imagery Rescripting)** y el diálogo en sillas múltiples para proteger al "Niño Vulnerable", limitar al "Padre Crítico/Punitivo" introyectado y fortalecer al "Adulto Sano".
- **Paso 3 (Ruptura de Patrones Conductuales):** Romper la rendición, evitación y sobrecompensación en la vida diaria mediante experimentos conductuales asertivos.
- **Paso 4 (Monitorización Anual):** Una reducción en las medias de esquemas activos de ≥ 1.0 punto confirma la reestructuración profunda de los esquemas tempranos.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD POR EVITACIÓN

Identificación: Varón de 31 años, diseñador gráfico, acude por profunda sensación de soledad, ansiedad social paralizante y bloqueo amoroso persistente. Manifiesta convicción íntima de que "si alguien me conoce de verdad, verá lo defectuoso que soy y me rechazará". Cumple criterios de Trastorno de la Personalidad por Evitación.

Evaluación Inicial YSQ-S3 (Línea Base): Puntuaciones medias en esquemas nucleares dominantes: **Imperfección / Vergüenza = 5.6/6.0**; **Aislamiento Social = 5.2/6.0**; **Abandono = 4.4/6.0**; **Subyugación = 4.2/6.0**. Estilo de afrontamiento predominante: Evitación esquemática extrema (trabajo remoto sin salir de casa).

Tratamiento Aplicado: Terapia de Esquemas (40 sesiones). Se implementó reparentalización limitada, rescritura en imaginación de memorias de acoso escolar en la infancia y confrontación compasiva de la voz crítica introyectada mediante la técnica de las dos sillas.

Reevaluación a los 14 Meses: Imperfección descendió a **2.4/6.0** (-3.2 pts); Aislamiento Social bajó a **2.2/6.0** (-3.0 pts); Abandono a **2.6/6.0**. El paciente logró integrarse a un colectivo presencial de diseñadores e inició su primera relación de pareja estable.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

CONTAMINACIÓN POR ESTADO AFECTIVO:

Durante episodios depresivos mayores severos, las puntuaciones del YSQ-S3 pueden inflarse artificialmente por el sesgo negativo del estado anímico. Diferenciar los esquemas estructurales crónicos de la distorsión cognitiva transitoria del episodio activo.

GESTIÓN DE LA SOBRECENSACIÓN:

En pacientes narcisistas o paranoides, la sobrecompensación puede ocultar los esquemas de Imperfección o Vulnerabilidad tras puntuaciones máximas en Grandiosidad (ME). Contrastar el autoinforme con la observación conductual en consulta.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Schema therapy: A practitioner's guide*. Guilford Press.
2. Young, J. E. (2005). *Young Schema Questionnaire – Short Form 3 (YSQ-S3)*. Schema Therapy Institute, New York.
3. Calvete, E., Orue, I., & González-Díez, Z. (2013). An examination of the structure and stability of early maladaptive schemas by means of the Young Schema Questionnaire-3. *European Journal of Psychological Assessment*, 29(4), 283-290.
4. Cid, J., et al. (2013). Psychometric properties of the Young Schema Questionnaire in Spanish clinical samples. *Journal of Clinical Psychology*, 69(6), 641-655.